

Uimastisõltlaste rehabilitatsioon vanglasüsteemis



Tõnis Palgi

sotsiaaltöötaja, Tartu vangla

Eesti vanglates kannab praegu karistust veidi alla 900 kinnipeetava, kellel on diagnoositud sõltuvus narkootilisest aineist (ligikaudu 32% kõigist kinnipeetavatest). Uimastisõltuvus on üpris määrava tähtsusega kuritegeliku käitumise kordumist soodustav tegur. Sõltuvushäire kontrolli alla saamine võib mõne õigusrikkuja jaoks oluliselt maandada uute kuritegude toimepanemise riski.

Artikkel annab ülevaate uimastisõltlaste taasühiskonnastamisest Eesti vanglasüsteemis, keskendudes reaalselt vanglakaristust kandvate uimastisõltlaste kohtlemisele.

Üksus sõltuvusdiagnoosiga kinnipeetavatele

Uimastisõltlaste rehabilitatsioon vanglas on korraldatud keskselt: kogu tegevus toimub vastava kontseptsiooni kohaselt. Iga-aastaselt kontseptsiooni ajakohastamisel osalevad kõik kaasatud spetsialistid, kes vaatavad üle selle vastavuse reaalsele vajadusele. Ressursside efektiivse kasutamise ja teenuse kvaliteedi tagamiseks on sõltuvushäirega kinnipeetavad koondatud Tartu vangla spetsiaalsesse üksusesse. 176kohalise sõltuvusrehabilitatsiooni üksuse töö eesmärk on tekitada kinnipeetavas tahe tegeleda sõltuvushäirega, et edaspidi elada täisväärtuslikku ja õiguskuulekat elu. Üksusesse pigutamise aluseks on arsti või

psühhiaatri poolt diagnoositud sõltuvus narkootilisest aineist. Lisaks kehtib nõue, et viimasest uimastitarvitamisest peab üksusesse suunataval kinnipeetaval olema möödas kõige rohkem aasta. Üksuses viibivatele kinnipeetavatele tagatakse igakülgne ravi (ka metadooni asendusravi) ja võimalus osaleda tervenemist soodustavates rehabilitatsiooniprogrammides.

Selle aasta juulikuu seisuga oli ligikaudu pooltel (48%) sõltuvusdiagnoosiga vangidest sõltuvus opioididest, 5%l kannabinoidide (marihuaana) tarvitamisest tingitud sõltuvus, 18%l muude stimulaatorite (nt amfetamiin) tarvitamisest tingitud sõltuvus ja 27% olid tarvitanud mitmeid või muid narkootilisi aineid. 2%l sõltuvusega kinnipeetavatest olid ülejäänud diagnoosid, sh sõltuvus kokaiini, rahustite, uinutite või lenduvate lahustite (benssiini, nitrolahusti, atsetooni) tarvitamisest. Vanglasüsteemis pole eraldi sekkumisüksusi kinnipeetavatele, kellel on diagnoositud alkoholi või tubaka tarvitamisest tingitud käitumis- ja psüühikahäired; nendega töötavad üldistel alustel meditsiini- ja taasühiskonnastamise osakonna spetsialistid ning kontaktisikud. Kinnipeetavatele, kes ei vasta sõltuvusrehabilitatsiooni üksuse kriteeriumitele, pakutakse sekkumisprogramme üldistel alustel – nad ei viibi küll spetsiaalses üksuses, kuid saavad osaleda sotsiaalprogrammides

(sh ka sõltuvusriski maandamiseks), neile on tagatud ravi ja teised taasühiskonnastavad tegevused. Kinnipidamisasutustes viibivatest uimastisõltlastest ligikaudu pooled on sõltuvuse remissiooni faasis (viimati sõltuvusainet tarvitanud üle aasta tagasi), ligikaudu 20% on vahistatu staatuses.

Sõltuvusrehabilitatsiooni üksuse töö planeerimisel lähtutakse seisukohast, et võõrutusseisus sõltlasel on säilinud kontakt selle reaalsuse ja seisunditega, mis tingisid ja toetasid tema sõltuvuskäitumist, seetõttu on väga tähtis kohese riskipõhise sekkumise põhimõte. Üksnes kontrollitud keskkonnas viibimisest sõltuvushäire kontrolli alla saamiseks jääb aga väheks, kuigi inimene ise võib innukalt uskuda, et kuna on vangistuse ajal toime tulnud ilma uimastiteta, siis saab ta hakkama ka pärast vabanemist.

Individuaalne lähenemine

Vangistusseaduse nõuetest lähtudes koostatakse igale üle aastase karistusajaga kinnipeetavale individuaalne täitmiskava, milles on fikseeritud tema vabastamise ettevalmistamiseks vajalikud abinõud. Sõltuvusrehabilitatsiooni üksuse kinnipeetavate individuaalne täitmiskava sisaldab lisaks haridustee jätkamisele või tööharjumuse kujundamisele ka sõltuvusrehabilitatsiooni seotud eesmäärke, nt osalemist sekkumisprogrammides.

Üksuses tegutseb kuus inspektor-kontaktisikut, kelle ülesanne on konkreetse kinnipeetava juhtumi korraldamine: tema riskide hindamine, riske maandavate tegevuste planeerimine ja nende ellu viimine, tegevuste täitmise ja riskide muutuse hindamine, samuti igapäevaelu puudutavate küsimuste lahendamine. Regulaarselt hinnatakse kinnipeetava motivatsiooni sekkumistegevusteks ja rehabilitatsiooni edenemist.

Üksuses on neljaastmeline süsteem, kus kinnipeetav liigub astmete vahel vastavalt sellele,

kuivõrd on ta motiveeritud oma sõltuvuskäitumist muutma. Üksusesse saabuvad ja väga madala motivatsiooniga kinnipeetavad asuvad esimesel astmel, kus rehabilitatsiooni põhirõhk on innustada kinnipeetavat sõltuvuskäitumist muutma. Teisel astmel on kinnipeetav omandanud mõningase motivatsiooni ja osaleb aktiivse rehabilitatsiooni ettevalmistavates tegevustes. Aktiivne rehabilitatsioon toimub kolmandal astmel. Neljas aste keskendub muutuse kinnistamisele ning avavanglasse paigutamise ja vabanemise-eelsete toimingute ettevalmistamisele.

Sekkumisprogrammid ja toetavad tegevused

Taasühiskonnastamise toetamiseks on kõrgema motivatsiooniga kinnipeetavad paigutatud 44kohalisse aktiivse rehabilitatsiooni osakonda, kus lisaks individuaalses täitmiskavas määratud sekkumisprogrammidele on võimalus osaleda toetavates tegevustes: joogas, vabastavas hingamises, loomaterapias, spordiprogrammides kehalise aktiivsuse säilitamiseks või loovtegevustes. Oluliseks on peetud rehabilitatsiooni soodustava õhkkonna kujundamist, osakond on olnud tubakavaba alates selle loomisest. Soodustatakse süüdimõistetute eneseabigruppe. Regulaarselt tegutsevad anonüümsete narkomaanide (AN) tugigrupid ning oma koht on ka kristlikul tugigrupil, mida samuti viivad läbi kinnipeetavad ise.

Sekkumisprogramme viivad ellu üksuse struktuuri kuuluvad psühholoog ja kaks sotsiaaltöötjat. Peamine sekkumiste lähtealus on motiveeriv intervjuerimine (MI), mis on osutunud asendamatuks meetodite kogumiks klientides muutumissoovi esile kutsumiseks ja arendamiseks, aga ka kogu tööprotsessi hindamiseks. Üksusesse suunatud vangid saavad esmalt osaleda tervist ja sõltuvushäire olemust puudutavas loengutsükli. Hea

koostöö on Eesti HIV-positiivsete võrgustikuga. Tervisegruppidesse ja loengutsükklitesse kaasatakse ka metadooni asendusravi saavaid kinnipeetavaid. Tervenemisele ja kainusele keskendunud programmidesse (nt 12 sammu tugigrupp) on oodatud need, kelle metadooni asendusravi on lõppenud.

Peamise sõltuvuskäitumise muutmist motiveeriva programmina kasutatakse kog-nitiiv-käitumuslikule teooriale tuginevat eluviisitreeningut, mis tegeleb muutumise motivatsiooni puudutavate teemadega, tekitab huvi sõltuvushäire kontrollimise ja tagasilanguse ennetamise meetodite vastu. Kõige olulisemaks rehabilitatsiooniprogrammiks on saamas motiveerivale intervjuerimisele tuginev programm „Jõud muutuda” (ingl *Strength to Change*), millega antakse osalejatele aktiivne roll muutuse suunas liikumiseks ning toetatakse tema isikust lähtuvat positiivset ressursi muutumiseks.

Tugi pärast vabanemist

Rehabilitatsiooniprotsessi kestlikkuse huvides ärgitatakse kinnipeetavaid pärast vabanemist osalema AN tugigruppides ning toetava keskkonna puudumisel või suurema sekkumisvajaduse ilmnemisel pöörduma rehabilitatsioonikeskusesse. Viimase kasuks otsustab vanglast vabanevate kinnipeetavate ilmselge vähemus. Siiski ei jää kõik kinnipeetavad pärast vanglast vabanemist omapäi – suur osa süüdimõistetutest vabaneb vangistusest tingimisi enne tähtaega ja osa jääb ka karistusjärgse käitumiskontrolli alla ning nendega tegelevad edasi kriminaalhooldusametnikud, kes viivad läbi sekkumisprogramme ja pakuvad individuaalset tuge ning teostavad järelevalvet. Kinnipeetavatel on võimalik saada tugisik, kes alustab temaga tööd juba karistuse ajal ning aitab lahendada ka praktilisi küsimusi, näiteks eluasemeprobleeme. Tähtajal vabanevad kinnipeetavad saavad oma

elu korraldada koos kohaliku omavalitusega, keda enne isiku vabanemist teavitatakse kirjalikult, milliseid tegevusi konkreetne inimene vangistuse ajal läbis ning antakse nõu, mida edaspidises töös silmas pidada.

Süsteemi kitsaskohad

Sekkumisprogrammide läbiviijad vanglasüsteemis näevad suurima raskusena asjaolu, et ligikaudu 80% tööst toimub vene keeles. Ehkki kinnipeetavatel on võimalik õppida riigikeelt, on enamiku keeleoskus siiski programmides osalemiseks ebapiisav. Riigikeele oskuse viimine tasemeni, mis seda võimaldaks, võib võtta küllaltki kaua ja ei haaku kohese riskipõhise sekkumise põhimõttega.

Samuti ei saa mööda vaadata tõsiasjast, et üks psühholoog ja kaks sotsiaaltöötajat üksuse 176 kinnipeetava kohta on liiga vähe. Arvestades, et kõigile kinnipeetavatele tuleb hoolimata nende motiveeritusest läbi viia individuaalses täitmiskavas ettenähtud programmid, jääb rehabilitatsioon pahatihti formaalseks. Seda mõjutab ka asjaolu, et individuaalse täitmiskava tegevusi kavandatakse kvartali kaupa, kuid inimese arengut ei ole võimalik sel viisil planeerida.

Sekkumistegevuste efektiivsust mõjutab ka see, et enamik kinnipeetavaid soovib rehabilitatsiooni läbida selleks, et pääseda avavanglasse või vabaneda tingimisi enne tähtaega.

Kinnipeetavate motivatsioon sõltuvushäirega tegeleda on väga erinev. Selliseid inimesi, kes probleemi teadvustavad ja on nõus tegema konkreetseid jõupingutusi sõltuvushäirega tegelemiseks, pole kuigi palju. Samas ei tohiks see olla ka suur üllatus: 2011. aastast avanenud alternatiivset karistuse kohaldamise meetod, vangistuse asendamist raviasutusse suunamisega, on süüdimõistetud uimastisõltlased kasutanud tagasihoidlikult. Huvi on väike, kuna ravile suunamise eelduseks on isiku vaba tahe ja soov probleemiga tegeleda.

Suure osa uimastisõltlaste ainuke rehabilitatsioon toimub vangistuse ajal, mis on ka paljude uimastisõltlaste puhul see napp aeg, mil nad

riiklike süsteemidega kokku puutuvad. Seega ei saa vanglas toimuva rehabilitatsiooni olulisust hoolimata selle kitsaskohtadest alahinnata. **S**

